

		☒ ACOMPANHAMENTO		☐ CONSULTA	
		NS			
JUNIA DURANTE LANDIM					
IDADE: 81	PESO: 76	ALTURA: 165	PROFISSÃO: Do lar		
SINTOMAS: Causado /					
QUEIXAS: Memória Ruim (esquece os compromissos) /					
MEDICAMENTOS: Glifage / Forviga / Hidroclorotiaz. / Afix /					
HAS / pm / Colesterol / CA 2007 / CA 2024 / a romazina / Xarelto.					
MÉDICO: Dr. Henrique / Dr. Mário / Exitalopran / Medat.					
MARCAPASSO: ☒ S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N					
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz					
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S		ALMOÇO: S		LANCHE: S JANTAR: 22	
HORA QUE DORME: 00:00 / 1:00		HORA QUE ACORDA: 10:00			
COCHILHO ☒ SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL			
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO					
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:					
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 1 X			
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:			
OVERLAP: Não	MALLAMPATI:	IAH: 33,5 e/h	SPO2: 95%		
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:					
CIRURGIAS: ☒ NASAL (S) AMIGDALECTOMIA					
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:					
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (S) CARDÍACA marcaç.					
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Perda memória					
Der no olhos.					
15/03 - Natacao marc. minage Fx					
28/03 - P= 5-8,6 cmH ₂ O (mediana 7,7)					
24 m de uso: 8h 21m					
fuga: 1,9 l/min					
IAH: 1,1 e/h					
Relata demora p/ dormir, fz uso de zolpidem					
Natacha					
11/04/24 P= 8cmH ₂ O (min 6,0 cmH ₂ O)					
IAH= 1,3 e/h					
m. de uso: 7h 40'					
Jua					
16/05 P= 8cmH ₂ O					
24 IAH= 1,5 e/h					
m. de uso: 6h 45'					
Jua					
20/06/24 P= 8cmH ₂ O					
IAH= 0,8 e/h					
m de uso: 8h 41m					
fuga: 22,8 l/min					
Bem adaptada					
Natacha					
18/07 P= 8cmH ₂ O					
24 IAH= 1,1 e/h					
m. de uso= 8					
Jua.					

19/08/24

P = 8cm H₂O

IAH = 1,5 e/h

m. de uso: 5h 18'

flua cláudio

02/09/24

P = 8cm H₂O

IAH = 1,3 e/h

m. de uso: 8h 26'

flua.

01/10/24

P = 8cm H₂O

IAH = 1,5 e/h

m de uso: 8h 18'

Watacha

11/11/24

P = 8,0 cm H₂O

IAH = 1,6 e/h

m uso = 8h 16 min

Tez no procedimento no rosto
na urea 7 dias
mas está Bem Adaptada

Silvia

13/01/25

P = 8,0 cm H₂O

IAH = 1,7 e/h

m uso = 5h 30'

fuga = 21 e/h min.

7,6 cm H₂O.

Novo filtro

* parando o neuro *
nova medicação.

Silvia

08/05/25

P = 8.0 cm H₂O

IAH = 0,9 e/h

M. de uso: 8h 46'

Bem adaptado.

flua cláudio

26/06/25

P = 8.0

IAH = 1.0

m. de uso: 9h.

Bem adapt. q/ (manis de descarcar a pele do nariz)

flua

DR ALBERTO REMESAR
PSIQUIATRIA
**LAUDO DA
POLISSONOGRAMA**

ANA CLAUDIA

NOME: Júnia Durante Landim
EXAME nº: 5561
SOLICITADO POR: Dr. Mário Silva Jorge
DATA: 31/01/2024
IDADE: 81 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h20min e concluído às 06h07min. A latência para o sono foi de 12 minutos e a latência para o estágio REM, de 354 minutos. O tempo total de sono foi de 358,5 minutos (05h58min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 88%. A distribuição do sono mostrou 21,2% de estágio 1, 71,1% de estágio 2, 1,8% de estágio 3 e 5,9% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 37 minutos em vigília, ocorreram 145 microdespertares (índice: 24,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 94,2/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 33,5/hora, sendo 8 apneia/hora e 25,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 47/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 88% e a mínima de 75%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (33,5/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (47/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 59; máxima: 64 bpm.

O ronco foi intermitente e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 12 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (354 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono manter-se no limite da normalidade (88%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 24,3/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (21,2%; normal: 8-10%) e 2 (71,1%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (1,8%; normal: 10-12%) e REM (5,9%; normal: 20%).

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (94,2/hora; índice normal até 15/hora).

Escala de Sonolência de Epworth: 5 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM SP 69.730